Agonistas del receptor de GLP-1 en el tratamiento de la obesidad

Dra. Omidres Pérez de Carvelli · 30 minutos grabados · entrega de la grabación: jueves 5 de noviembre · se publica el jueves 12 de noviembre

Qué cubre la clase y qué deja a otras

Sí entra	No entra · dónde se cubre
• Mecanismo de acción de los agonistas de GLP-1 y por qué reducen el peso • Semaglutida y liraglutida: dosis, escalada y manejo práctico • Evidencia en obesidad: programas SCALE, STEP y OASIS • Qué pasa al suspender el fármaco • Efectos adversos y cómo manejarlos	• Tirzepatida y terapias nuevas → M3 · C3, Dra. Cuatecontzi • Agonistas de GLP-1 en diabetes → M4 · C3, Dra. Jiménez • Beneficio cardiovascular y renal → M6 · C3, Dr. Chen Ku • Alimentación durante el tratamiento → M5 · C3, Dra. Machado • Fármacos clásicos para obesidad → M3 · C1, Dr. Vanegas

Dos reglas de esta clase. Solo **denominaciones genéricas** (semaglutida, liraglutida), nunca marcas: uno de los auspiciantes del curso comercializa un agonista de GLP-1. Y la primera diapositiva después de la portada es la **declaración de conflictos de interés**.

Cronograma minuto a minuto

Minuto	Bloque	Temas y subtemas	Referencias
00:00 – 02:00	**Apertura**	• Presentación y título de la clase • Declaración de conflictos de interés • Tres objetivos: entender cómo actúan, conocer la evidencia en obesidad y saber manejar los efectos adversos	—
02:00 – 07:00	**1 · Mecanismo de acción**	• GLP-1 endógeno: hormona intestinal, vida media de minutos • El agonista farmacológico: resistente a la degradación, vida media prolongada • Acción central: hipotálamo y tronco encefálico → más saciedad, menos apetito • Retraso del vaciamiento gástrico • Secreción de insulina dependiente de glucosa e inhibición del glucagón (solo mencionarlo: el detalle glucémico es de M4 · C3) • Mensaje: el peso baja porque el paciente come menos, no por pérdida de calorías por el intestino	Drucker 2018 [1]
07:00 – 10:00	**2 · Moléculas y dosificación**	• **Liraglutida 3,0 mg** subcutánea, una vez al día • **Semaglutida 2,4 mg** subcutánea, una vez por semana; escalada de 16 semanas hasta la dosis de mantenimiento • Si no tolera 2,4 mg: STEP 8 permitió quedarse en 1,7 mg • **Semaglutida oral 50 mg** diaria: evidencia de fase 3 (OASIS 1) • Diapositiva práctica: la tabla de escalada y qué hacer si se olvida una dosis	STEP 4 [5] · STEP 8 [7] · OASIS 1 [10] · ficha técnica (FT)

Minuto	Bloque	Temas y subtemas	Referencias
10:00 – 18:00	**3 · La evidencia en obesidad**	• **SCALE**, liraglutida 3,0 mg, 56 semanas: –8,4 kg frente a –2,8 kg con placebo; 63,2 % perdió ≥5 % del peso • **STEP 1**, semaglutida 2,4 mg, 68 semanas: –14,9 % frente a –2,4 %; la mitad perdió ≥15 % • **STEP 3**, con terapia conductual intensiva: –16,0 % frente a –5,7 % • **STEP 5**, dos años: –15,2 % frente a –2,6 %; el efecto se sostiene • **STEP 8**, comparación directa: semaglutida –15,8 % frente a liraglutida –6,4 % • **STEP 2**, persona con obesidad y diabetes tipo 2: –9,6 % frente a –3,4 % (la pérdida es menor; el resto, en M4 · C3) • **STEP TEENS**, adolescentes: IMC –16,1 % frente a +0,6 % • **OASIS 1**, vía oral 50 mg: –15,1 % frente a –2,4 % • Una sola línea sobre **SELECT** (eventos cardiovasculares) y remitir a M6 · C3	[2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [10] · SELECT [14]
18:00 – 21:00	**4 · Al suspender el tratamiento**	• **STEP 4**: tras 20 semanas con semaglutida, quien siguió perdió otro 7,9 %; quien pasó a placebo recuperó 6,9 % • **Extensión de STEP 1**: un año después de suspender, se recuperaron dos tercios del peso perdido y los factores cardiometabólicos volvieron hacia el inicio • Mensaje: la obesidad es una enfermedad crónica; el tratamiento también lo es. Hay que hablarlo con el paciente antes de empezar	STEP 4 [5] · STEP 1 ext. [11]
21:00 – 27:00	**5 · Efectos adversos y su manejo**	• **Gastrointestinales** (STEP 1 a 3): náuseas 43,9 % frente a 16,1 %; diarrea 29,7 %; vómitos 24,5 %; estreñimiento 24,2 %. Casi todos leves o moderados, transitorios y concentrados en la escalada; solo 4,3 % suspendió por ellos. La pérdida de peso **no** depende de tener náuseas • Manejo: escalar despacio, no subir la dosis si persisten los síntomas, porciones pequeñas (el detalle nutricional va en M5 · C3) • **Vesícula y vías biliares**: metaanálisis de 76 ensayos, RR 1,37; mayor en ensayos de pérdida de peso (RR 2,29), con dosis altas y uso prolongado • **Neuropatía óptica isquémica (NAION)**: una cohorte retrospectiva de un solo centro encontró asociación; es una señal, no una causalidad demostrada • **Cirugía y endoscopia**: riesgo de contenido gástrico retenido; la guía multisocietaria de 2024 recomienda estratificar el riesgo y decidir en conjunto si se suspende • Contraindicaciones y precauciones de la ficha técnica: antecedente personal o familiar de carcinoma medular de tiroides o MEN 2, pancreatitis, embarazo (FT)	Wharton 2022 [12] · He 2022 [13] · Hathaway 2024 [15] · Kindel 2024 [16] · ficha técnica (FT)
27:00 – 30:00	**Cierre**	• Tres mensajes: 1. Actúan sobre el apetito y la saciedad; la pérdida de peso es clínicamente relevante y se sostiene a dos años 2. Al suspenderlos, el peso vuelve: se plantean como tratamiento crónico 3. Los efectos gastrointestinales se previenen con una escalada lenta • Puente a la clase siguiente: tirzepatida y terapias nuevas (M3 · C3)	—

(FT) = dato de ficha técnica, no de un artículo. Verificarlo con la ficha aprobada por ARCSA antes de grabar. Qué presentaciones están disponibles hoy en Ecuador: **POR CONFIRMAR**.

Tu calendario hasta la entrega

Hasta el miércoles 22 de octubre	Diapositivas armadas con este guion
Jueves 23 – lunes 27 de octubre	Ensayo cronometrado: cada bloque dentro de su tiempo
Hasta el lunes 2 de noviembre	Grabación en la sala de Zoom del curso
Jueves 5 de noviembre	Fecha límite de entrega
Jueves 12 de noviembre	Se publica con el módulo 3

Fechas intermedias propuestas para dejar margen; solo la del 5 de noviembre es fija.

Referencias

Verificadas en PubMed el 14 de octubre de 2026. Las cifras del cronograma están tomadas del resumen publicado de cada artículo.

1. Drucker DJ. Mechanisms of action and therapeutic application of glucagon-like peptide-1. Cell Metab. 2018;27(4):740-56. doi:10.1016/j.cmet.2018.03.001

2. Pi-Sunyer X, Astrup A, Fujioka K, et al. A randomized, controlled trial of 3.0 mg of liraglutide in weight management. N Engl J Med. 2015;373(1):11-22. doi:10.1056/NEJMoa1411892

3. Wilding JPH, Batterham RL, Calanna S, et al. Once-weekly semaglutide in adults with overweight or obesity. N Engl J Med. 2021;384(11):989-1002. doi:10.1056/NEJMoa2032183

4. Wadden TA, Bailey TS, Billings LK, et al. Effect of subcutaneous semaglutide vs placebo as an adjunct to intensive behavioral therapy on body weight in adults with overweight or obesity: the STEP 3 randomized clinical trial. JAMA. 2021;325(14):1403-13. doi:10.1001/jama.2021.1831

5. Rubino D, Abrahamsson N, Davies M, et al. Effect of continued weekly subcutaneous semaglutide vs placebo on weight loss maintenance in adults with overweight or obesity: the STEP 4 randomized clinical trial. JAMA. 2021;325(14):1414-25. doi:10.1001/jama.2021.3224

6. Garvey WT, Batterham RL, Bhatta M, et al. Two-year effects of semaglutide in adults with overweight or obesity: the STEP 5 trial. Nat Med. 2022;28(10):2083-91. doi:10.1038/s41591-022-02026-4

7. Rubino DM, Greenway FL, Khalid U, et al. Effect of weekly subcutaneous semaglutide vs daily liraglutide on body weight in adults with overweight or obesity without diabetes: the STEP 8 randomized clinical trial. JAMA. 2022;327(2):138-50. doi:10.1001/jama.2021.23619

8. Davies M, Færch L, Jeppesen OK, et al. Semaglutide 2·4 mg once a week in adults with overweight or obesity, and type 2 diabetes (STEP 2): a randomised, double-blind, double-dummy, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2021;397(10278):971-84. doi:10.1016/S0140-6736(21)00213-0

9. Weghuber D, Barrett T, Barrientos-Pérez M, et al. Once-weekly semaglutide in adolescents with obesity. N Engl J Med. 2022;387(24):2245-57. doi:10.1056/NEJMoa2208601

10. Knop FK, Aroda VR, do Vale RD, et al. Oral semaglutide 50 mg taken once per day in adults with overweight or obesity (OASIS 1): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2023;402(10403):705-19. doi:10.1016/S0140-6736(23)01185-6

11. Wilding JPH, Batterham RL, Davies M, et al. Weight regain and cardiometabolic effects after withdrawal of semaglutide: the STEP 1 trial extension. Diabetes Obes Metab. 2022;24(8):1553-64. doi:10.1111/dom.14725

12. Wharton S, Calanna S, Davies M, et al. Gastrointestinal tolerability of once-weekly semaglutide 2.4 mg in adults with overweight or obesity, and the relationship between gastrointestinal adverse events and weight loss. Diabetes Obes Metab. 2022;24(1):94-105. doi:10.1111/dom.14551

13. He L, Wang J, Ping F, et al. Association of glucagon-like peptide-1 receptor agonist use with risk of gallbladder and biliary diseases: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. JAMA Intern Med. 2022;182(5):513-9. doi:10.1001/jamainternmed.2022.0338

14. Lincoff AM, Brown-Frandsen K, Colhoun HM, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in obesity without diabetes. N Engl J Med. 2023;389(24):2221-32. doi:10.1056/NEJMoa2307563

15. Hathaway JT, Shah MP, Hathaway DB, et al. Risk of nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy in patients prescribed semaglutide. JAMA Ophthalmol. 2024;142(8):732-9. doi:10.1001/jamaophthalmol.2024.2296

16. Kindel TL, Wang AY, Wadhwa A, et al. Multisociety clinical practice guidance for the safe use of glucagon-like peptide-1 receptor agonists in the perioperative period. Surg Obes Relat Dis. 2024;20(12):1183-6. doi:10.1016/j.soard.2024.08.033